

單元1 | 情緒焦點治療督導的基礎：理論、原則與督導者角色

對應原書：叢書序 (pp. vii–xii) + 第1章 Introduction (pp. 3–27) 來源：Greenberg, L. S., & Tomescu, L. R. (2017). *Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy*. APA. 本檔內容：學習目標 | 完整學術摘要 | 核心概念洞見 | 關鍵原文引述 | 臨床推理框架

標示說明：「原教材指出」表示內容直接來自原書；「從臨床實務角度」表示本教材的延伸詮釋；「相關文獻」表示原書以外的一般知識。文中簡例均為綜合改寫之假想情境。

本單元學習目標

完成本單元後，你能夠：

1. 能說明辯證建構主義如何解釋「情緒被建構而成為意識感受」，並據此說明 EFT 為何以「功能不良的處理風格」取代「精神病理」來理解個案。〔理解／概念化〕
2. 能區分原發適應性、原發非適應性、次發反應性與工具性情緒；在一段假想個案陳述中運用四項情緒評估準則判斷其類型，並選擇相應的處理方向。〔分析／評估〕
3. 能以六大 EFT 原則分析一段督導或晤談片段，指出哪些回應體現了「跟隨與引導」、「歷程診斷」與「知覺技能」，哪些違反了這些原則。〔分析／介入〕
4. 能辨識督導者在一段督導對話中採取的角色（教師／諮商者／顧問），判斷該回應屬於一致或不一致的督導事件，並提出改寫。〔評鑑／反思實務〕
5. 能評估督導中出現受督者個人議題時，督導者的界線是否恰當（徵得同意、單次、事件本位、轉介），並說明倫理理由。〔評鑑／倫理〕
6. 能以文化敏感的方式，說明集體主義背景的個案表達憤怒時，治療師與督導者可如何兼顧「共同情緒核心」與「文化表達規則」，並指出普世主義立場的限制。〔評鑑／文化〕
7. 能示範以「可以做」而非「對／錯」的語言給同儕一則矯正性回饋，並自評其是否被感受為支持。〔應用／治療關係〕

§2 完整學術摘要

A. 主題與背景

本單元要回答的問題

「一位情緒焦點治療師是怎麼被帶出來的？」這個問題看似行政性，實際上觸及臨床訓練的核心難題：知道 EFT 的理論，和能在晤談中辨認出此刻個案的悲傷底下還有羞愧、並且在對的時間以對的方式回應，是兩種完全不同的能力。本書試圖回答的，是後者要如何透過督導習得。

為什麼督導本身值得研究

叢書序替全書搭好背景，提出三個論點：

1. 督導是一項獨立的专业活動。原教材引用 Bernard 與 Goodyear 的定義：督導是由專業中較資深者提供給較資淺同業的介入，這段關係具評鑑性與階層性、會持續一段時間，並同時有三個目的：提升受督者的專業功能、監督其提供給個案的服務品質、為專業把關（守門）。叢書主編強調，「好治療師」不會自動成為「好督導者」，督導也無法只靠講授學會。
2. 督導已被視為心理師的核心能力領域。序中列出美國心理學會（APA, 2014）《健康服務心理學臨床督導指引》的基本假設，例如：督導需要正式教育與訓練；以個案福祉與保護大眾為優先；在尊重且合作的關係中進行，這段關係需要建立、維持，必要時修復；督導是雙向回饋；需要整合多元文化；有守門功能；並且不同於諮詢、個人治療與師徒指導。
3. 幾乎每位治療師遲早都會成為督導者。序中引述 Rønnestad 等人（1997）的調查：85%–90%的治療師在執業頭15年內會擔任臨床督導者。

對碩士生的意義（從臨床實務角度）：你現在是受督者，但你正在內化的「被督導經驗」，就是你未來擔任督導者時的原型。本書的作者之一 Tomescu 也自述，她的督導觀念大量來自當受督者的經驗。

本書在臨床心理學中的位置

原教材指出，EFT 雖然已發展成一個具實證支持的治療取向，卻仍缺乏一個明確界定的督導模式。本書目的是提出一個以事件為本位（event-based）、以任務分析（task analysis）為方法的 EFT 督導模式，讓督導者與受督者都有一張清楚的「督導地圖」，並為未來研究督導歷程與結果打下基礎。

EFT 督導與 EFT 治療共用兩個基本原則：關係與工作。督導包含以下要素：

- 建立安全的督導同盟；
- 為每次督導確認一個焦點，通常是受督者提出的兩難或困難；
- 辨識督導的任務標記，也就是適合督導者介入的時機；
- 在標記出現時介入；
- 確認解決是否達成。

EFT 督導者會仔細聽受督者的每一段晤談錄影，聚焦在個案逐刻（moment-by-moment）的處理歷程，以及受督者的回應。督導的重心放在培養看、聽與同理的技能，包括察覺非語言表達的瞬間變化、理解個案如何經驗事件，以及辨識晤談中的問題狀態標記與個案的微歷程。

B. 核心概念與重要定義

B1. 情緒焦點治療（Emotion-Focused Therapy, EFT）

- 定義：原教材描述 EFT 是一種具實證支持、以歷程為導向的治療取向。它屬於「新人本主義的經驗取向」（neohumanistic experiential approach），把人本原則、當代情緒理論與辯證建構主義的哲學立場獨特地整合在一起。

- 理論意涵：EFT 用當代語言重新詮釋人本傳統中的經驗中心性、自我決定與成長傾向。人被視為擁有一套與生俱來的情緒系統，這套系統是持續適應、建構意義與成長的基礎。情緒是人類經驗的基本資料，意義建構則負責理解情緒。情緒與認知的互動，是最主要的辯證歷程之一。
- 與相關概念的區分：EFT 與個人中心治療同源，但 EFT 更強調治療師是歷程專家，會主動引導；與完形治療同樣使用實驗，但 EFT 以研究界定了何時使用哪一種實驗。下文 B7「歷史源流」會再說明。
- 常見誤解：以為 EFT 就是「讓個案大哭一場」。原教材強調的是對情緒的覺察、調節、表達、轉化與反思，最終目標是理解情緒、創造新意義並強化自我。

B2. 辯證建構主義 (Dialectical Constructivism) 與情緒的建構

原教材的論點可以整理成四個環節：

1. 情緒最初以未分化的形式存在。情緒不是完整地躺在潛意識中，而是以前概念、前語言的感覺運動基模形式存在（引 Lane, 2008）。
2. 內隱情緒可以被轉為意識經驗。內隱的情緒，也就是身體感覺到的感受，可以藉由把感覺放進語言，轉化為對特定情緒的意識經驗。
3. 意識到的感受是多重歷程互動的產物。經驗是由情緒與記憶、注意力、學習、情境等心理歷程互動建構出來的，最後浮現一個被命名的感受。因此情緒與認知密不可分，最佳的適應是用敘事理解情緒，把理性與情緒整合起來。
4. 人是「動態的自我組織系統」。人持續重新組成「情境中的自我」（self-in-the-situation），並且是這個歷程中的能動者，因為人能引導注意力、建構意義。人也是說故事者，持續建構依狀態而變的敘事。自我具有多重性：有多種聲音、多個故事，情緒狀態也會快速轉換。

臨床意義：如果感受是「被建構」的，治療師的工作就不是「挖出」一個早已完整存在的情緒，而是協助個案注意身體感受、找到貼切的字詞並建構意義。這也說明了為什麼 EFT 治療師的回應措辭這麼重要：一句同理反映，本身就參與了個案感受的建構。

常見誤解：以為「建構」表示情緒是假的或任意的。原教材的意思是，情緒以生物性的情緒系統為基礎，而意識到的、被命名的感受是在互動中形成的。

B3. 先抵達，才能離開：接納先於改變

原教材指出，治療同時包含接納經驗與改變：個案必須先接納自己是誰，改變才可能發生；「個案必須先抵達一個地方，才能離開那個地方」（p. 6）。

- 臨床意義：急著讓個案「不要那麼難過」「換個角度想」，往往跳過了「抵達」這一步。
- 督導意義（從臨床實務角度）：受督者也一樣。受督者承認自己在晤談中很慌之前，很難學會在慌張中仍保持在場。

B4. 功能不良的情緒處理風格（取代「精神病理」）

原教材的立場很鮮明：個案不被視為經驗著精神病理，而是擁有一種功能不良的情緒處理風格（p. 6）。

原教材列出的功能不良處理機制有五種：

機制	說明	從臨床實務角度的示例
① 非適應性情緒被激發	在先前負向經驗中形成的情緒反應被再度觸發	一被批評就湧起童年被羞辱時的羞愧
② 意義建構過度僵化	僵固地套用同一種意義框架	「只要有人不回訊息，就代表我被討厭」
③ 經驗與表達不一致	內在感受與外在表達脫節	笑著描述被背叛
④ 無法符號化與表達情緒	感受無法被命名或說出	「我不知道，就是很悶」
⑤ 自我對立部分難以改變或整合	內在衝突的兩面卡住	一部分想離職，一部分嚴厲斥責自己軟弱

- 與相關概念的區分：這是歷程層次的描述，而不是疾病分類。它回答的是「此刻情緒如何被處理」，而不是「這個人得了什麼病」。
- 臨床意義：它把注意力從「標籤」移到「可以介入的歷程」。
- 常見誤解（從臨床實務角度）：以為「不看病理」就是可以忽略診斷、風險與醫療需求。原書第2章明確指出，碰到自殺風險、情緒調節嚴重不良或界線問題時，督導者必須直接、具體地指導（見單元2）。歷程診斷是 EFT 的工作焦點，不是不評估風險的理由。
- 原書立場的爭議性：「個案不經驗精神病理」是強烈的理論主張。在需要診斷來做轉介、保險給付、藥物評估或法律報告的場域（包括台灣的醫療體系），這個主張更適合被理解為介入層次的視角，而不是否認症狀或疾病的存在。這一點值得在課堂中討論。

B5. 這個觀點如何影響督導

原教材把「動態自我組織系統、處理風格功能不良而非人本身功能不良」的觀點同樣套用在受督者身上：

- 督導者協助受督者依歷程概念來概念化個案。
- 治療中出現困難時，督導者不以受督者的人格作評價。
- 督導同盟出現問題時，受督者不被視為「有病理、需要被處理」。不過，理解同盟裂痕是經由哪些人際歷程產生的，仍然是可以討論的。
- 督導者嘗試理解督導中的歷程困難，與受督者公開對話，並真誠地承擔自己作為「問題共同建構者」的責任。

B6. 情緒基模與敘事認同

- 情緒基模（emotion scheme）：一種心智組織模式，隱含地、在較高層次上組織情緒經驗。它會產生經驗，也會產生行動。個案的情緒基模處理系統是自我組織歷程的核心：多個情緒基模共同作用，產生一個統一的自我組織。原教材舉例，憂鬱的情緒基模通常圍繞著失落、覺得不被愛、覺得無價值或無能。
- 敘事認同（narrative identity）：比情緒基模更高一層的自我組織。敘事是一種建構意義的歷程，起初是非語言的、意象式的表徵，隨時間展開；它有開始、中間與結尾，也有情節，情節中主角的意圖涉入行動，並帶來影響與後果。

- 兩者的關係（從臨床實務角度）：情緒基模是「感受怎麼被組織」，敘事是「這些感受被說成什麼樣的故事」。EFT 同時處理兩者：轉化痛苦的情緒基模，並協助形成更一致的敘事。

B7. 督導的雙重焦點

原教材指出，EFT 督導永遠有雙重焦點：

1. 個案：協助受督者辨識個案主要的痛苦情緒基模，並發展更一致的敘事。
2. 受督者：持續關注受督者對個案的情緒反應，協助受督者理解督導經驗，進而形成更一致、整合的專業認同。

這個組合能提升受督者對實務的信心，也讓受督者更覺察自己的情緒。

B8. EFT 六大原則（同時用於治療與督導）

原教材列出六項 EFT 特有的原則，它們同時形塑治療與督導。原教材也清楚劃出一條界線：EFT 的失功能理論與治療理論不直接套用在督導上。督導不治療受督者的問題，也不試圖取用並轉化受督者的核心痛苦經驗，而是促進一種特定形式的學習。因此，督導者不在督導中對受督者明確地進行治療。

原則	在治療中	在督導中
① 跟隨與引導	治療師在場、逐刻跟隨個案的內在經驗（「把手指放在個案的情緒脈搏上」），同時是主動的歷程引導者與「情緒教練」。個案是自身經驗的專家（內容），治療師是促進下一步的專家（歷程）。兩者之間是辯證的創造性張力，不是矛盾	受督者最了解個案與自己的經驗。督導者不是受督者經驗的權威，而是歷程專家，擅長辨識督導任務並促進其解決。任務知識來自 EFT 的任務分析取向（Greenberg, 1984）
② 同理探索回應風格	以主動、投入但試探性的語氣，做探索性反映或提問	督導者拒絕「由專家獨自決定要處理什麼」，與受督者共同建構歷程概念化、督導目標與意義；主要任務是促進受督者注意個案的瞬間經驗
③ 歷程診斷，而非人的診斷	不以正式診斷為焦點，而是注意個案的處理風格、晤談中問題情緒狀態的標記、主要主題，並追隨個案的情緒痛苦，最後形成對痛苦情緒的概念化	以任務分析取向辨識督導中的標記，依受督者的需要，與受督者協議處理不同的受督者任務
④ 促進更深的情緒經驗與生產性處理	治療師提供的專業是：如何促進更深的經驗、如何協助覺察、取用、生產性地處理並轉化情緒、如何創造新意義	高度歷程導向：協助受督者認出可以深化情緒處理的標記，以及適合的治療任務；逐刻回饋如何回應個案以推進下一步。督導者首先是一位訓練者

原則	在治療中	在督導中
⑤ 學習與教導知覺技能	—	知覺技能是指知道何時介入，而不只是如何介入；也指能在臨床現象出現時注意到它。概念或理論技能讓人「理解」，卻不一定讓人「能在情境中應用」。受督者需要具體例子來做必要的知覺區辨，督導會依受督者的程度調整
⑥ 情緒與需求跨越文化	同理是仔細傾聽對方、聽出情緒的底音與未被說出的需求。人在核心上有共同需求：生存、成長、依附與歸屬、被重視與被認可；但表達與溝通情緒的規則因文化而異	督導者協助受督者抵達任何文化背景個案的核心情緒歷程，同時同理地理解個案或受督者的文化，並覺察文化中的表達規則與禁令

歷程引導（process guiding）的原文定義值得特別記住：治療師主動與個案合作，朝向三個方向：

- 活化更深的經驗與更具適應性的情緒回應，例如藉由活化底下較具肯定性的原發憤怒，改變個案的自責與無望；
- 進行晤談中的任務，例如解決未竟事務，或理解一個令人困惑的反應；
- 達成整體治療目標，例如協助個案走出過去的創傷經驗。

治療師的目標不是教導或改變個案，而是引導歷程。

標記（marker）與任務（task）：標記是晤談中的行為，顯示個案已準備好處理某個特定問題。任務是因應標記而合作展開的晤談內歷程與程序。例如，未竟事務標記是個案對生命中重要他人表達揮之不去的負面感受，相應的任務是與想像中的重要他人進行空椅對話，以解決受傷與憤怒。

B9. 四種情緒類型（知覺技能的核心區辨）

原教材指出，最關鍵的知覺技能之一，是區辨不同類型的情緒歷程。督導者的教法是在錄影中當場指出例子，並討論它在那一刻的功能。

類型	定義（原教材）	處理方式（原教材）	關鍵區辨線索（從臨床實務角度）
原發適應性情緒	自動處理複雜情境資訊後產生的反應，直接針對當下情境，讓人準備採取有效行動	需要被取用並更充分地允許，以提供資訊與行動傾向。治療師以同理回應，擔任「代理資訊處理者」，提供字詞讓個案比對是否貼切。例如：「這是你最底層、最核心的感受嗎？」「往內檢查看看，這是不是你最基本的感受？」	情緒與當下情境相稱；表達後常帶來清晰感、方向感或釋放；有明確的行動傾向
原發非適應性情緒	也是對情境的直接反應，但已無法協助人建設性地因應，反而干擾功能；通常是基於先前（常是創傷性）經驗的過度學習反應	協助個案接近、取用、符號化、調節並探索這些情緒；一旦被取用和接納而非逃避，就能經由取用另一種底層情緒加以轉化（例如以自我慈悲或自豪轉化非適應性羞愧），並透過反思理解它。治療師以同理探索與同理臆測協助取用	熟悉、反覆、「又來了」的感覺；強度與當下情境不相稱；表達後不會帶來新方向，反而讓人更卡住

類型	定義（原教材）	處理方式（原教材）	關鍵區辨線索（從臨床實務角度）
次發反應性情緒	跟在較原發的反應之後。人常會對最初的原發情緒產生情緒反應，於是原發情緒被取代，這就是「對反應的反應」。它會遮蔽或轉化原本的情緒，並帶出不完全適合當下情境的行動	以同理探索找出它所衍生的底層原發情緒，例如反應性憤怒底下的原發恐懼	情緒似乎「蓋住」了什麼；常見形式包括對悲傷的憤怒、對害怕的羞愧、無望與絕望；探索後常會轉變成另一種情緒
工具性情緒	被表達出來以影響他人，也就是具有人際功能或意圖影響他人的情緒	最好探索其人際功能或意圖。治療師在理解對方感到悲傷或生氣之後，可以說：「我在想，你是不是想藉著這份感受，向這個人表達某個重點、告訴他某件事？」如此，人能認出自己情緒中的意圖，可能是想保護自己、得到安慰或支配他人	情緒強度隨聽眾而變；有明確的「對誰說」；個案本身往往也覺察得到它的效果

關於這個分類的重要提醒：

1. 情緒類型是「功能」的判斷，不是「情緒名稱」的判斷。同樣是憤怒，可能是被侵犯時的原發適應性憤怒，可能是遮蔽恐懼的次發憤怒，可能是從小被欺負形成的非適應性憤怒，也可能是讓家人閉嘴的工具性憤怒。
2. 判斷是暫定的，而且是逐刻的。原教材強調督導者在錄影中「討論它在那一刻的功能」。同一位個案在同一次晤談中，情緒功能也可能改變。
3. 工具性情緒不等於「操弄」。原教材的處理方式是「探索其人際功能」，語氣是好奇的。把工具性情緒視為道德缺陷，會破壞同盟（從臨床實務角度）。

B10. 情緒評估的四項準則

原教材指出，為了協助受督者做情緒評估，督導者可以建議以下準則：

1. 觀察非語言表達：臉部表情、語調、事情是怎麼被說出來的。
2. 普世情緒反應的知識：例如人被侵犯時通常會生氣，失去重要他人時通常會悲傷。
3. 運用受督者自己對情境的情緒反應來評估個案的情緒。
4. 知道個案面對情境與他人時的特徵性反應方式：例如這位個案被他人忽視時，先覺得自己渺小，接著感到無望；或者，這位個案生氣時感到的是被拒絕，而不是羞愧。

從臨床實務角度：四項準則的證據來源各不相同，最好交叉使用，而不是只靠其中一項。準則①是當下觀察，準則②是常模性知識，準則③是治療師的主觀共鳴，準則④是個案的個人史與模式。只靠準則③，容易把治療師自己的反應投射到個案身上；只靠準則②，會忽略個別差異與文化差異。

B11. 任務的五大類別與「可以做」的實驗立場

原教材指出，EFT 已整合並研究了大量的個案標記與治療任務。為了方便理解，將它們歸為五大類：

- 同理本位任務
- 關係任務
- 經驗任務
- 再處理任務
- 演出任務

每一類任務都對應一些介入，要在督導中學習並熟練。（本書在第3章才列出具體的標記與任務，見單元3。）

原教材特別強調，督導者不是要訓練受督者機械地依步驟執行，而是鼓勵並協助受督者嘗試不同介入：起初只是試探性地嘗試，隨著時間越來越熟練、流暢。督導早期，介入概念被當作實驗與「可以做」（could do's）來介紹，而不是「只有一種正確做法」。這傳達出介入的彈性，也表示督導者的建議不是對錯的宣判，而是提供可能性，讓治療師依自己的風格與人格嘗試並逐步採納，也就是個人化或整合技能。

B12. 歷史源流：EFT 從哪裡來、又走到哪裡去

原教材指出，EFT 理論源自個人中心、完形與存在治療的整合，並透過現代認知與情緒理論重新詮釋。這三者合稱「第三勢力」，在 1960–70 年代席捲北美，成為行為主義與精神分析之外的另一種選擇。

源流	EFT 吸收了什麼	EFT 超越或修改了什麼
個人中心治療 (Rogers)	治療關係是內化價值條件的解藥，讓個案得到被看見、被理解、被無條件接納的新經驗。後來焦點擴展到促進個案新的經驗模式。Gendlin 認為「經驗」是具體的身體感受歷程，是心理現象的基本資料；最佳的自我歷程是體會到的意義與語言符號互動，產生明確的意義	Rogers 與 Gendlin 以經驗為存在的基本資料，EFT 則以情緒為基本前提，把經驗視為多層次處理默會合成後的衍生物。EFT 納入 Gendlin 的體感、生物演化的基本情緒觀 (Ekman & Davidson, 1994) 與情緒喚起。體感需要被注意並符號化，才能產生意義；類別性的基本情緒（恐懼、憤怒、悲傷）則需要被喚起並調節，才能取用需求與行動傾向
完形治療 (Perls 等)	整體的自我實現傾向；有機體智慧經由需求的自發浮現引導行動；歷程指導的風格；以分級實驗為主要介入形式	EFT 採用了多個關鍵的完形實驗，並更清楚地界定它們最適合何時使用、促進哪些導向改變的歷程
存在治療 (May, Yalom)	較寬廣的人性觀與終極關懷（自由、選擇、孤獨、意義）；失功能來自缺乏真實性、與經驗疏離，以及隨之而來的無意義、孤立與存在焦慮	EFT 認為這些關懷都相關，但也把情緒及其調節與符號化視為終極關懷

原教材的總結是：EFT 結合了完形的歷程指導風格、對取用並強化情緒經驗與覺察的強調，以及個人中心對提供安全感、分化經驗並建構意義的強調。讓經驗在覺察中鮮活起來、注意身體的體感、在覺察的邊

緣尋找並符號化體會到的意義，都是 EFT 的重點。

B13. 督導的定義

原教材先給出字典式的定義：督導是「觀看並指導某人做什麼、或某事如何被做，並確保一切都被正確完成的行動或歷程」，包含指導或監看一項活動的表現或運作，以維持秩序。

原教材接著引用 Bernard 與 Goodyear (2013) 的定義，拆解出四個成分：

1. 督導是一種介入，有獨特的能力與技能；
2. 由至少在某些重要面向更資深的臨床督導者提供；
3. 督導是持續一段時間的關係，會持續到足以讓受督者有發展性的進展，因此關係很重要；
4. 督導者評鑑、監督，並擔任守門者。督導者對受督者個案接受的照護品質負有倫理與法律責任。為了提升受督者的專業功能並確保照護品質，督導者持續監督並回饋受督者的表現。這種形成性評量是督導工作的基礎。

值得討論的張力（從臨床實務角度）：字典定義強調「確保一切被正確完成」，但本書同時強調「可以做」而非對錯、督導者不是絕對專家。這個張力並不矛盾，它反映的正是下文 B15 所說的「專家與共構者之間的辯證」：在個案安全與倫理層面，督導者確實要確保「正確」；在技術與風格層面，督導者提供的是可能性。

B14. 督導者的三種角色（Bernard 區辨模式）與 EFT 的採用方式

Bernard (1997) 的區辨模式提出三種角色。EFT 督導三者都採用，但各有特定用法：

角色	Bernard 的定義	EFT 的用法（原教材）	界線與注意事項
教師	督導者負責決定受督者需要什麼知識才能更勝任	更精確地說是訓練，因為許多技能必須在實際臨床情境中學習。EFT 對特定的晤談問題標記有高度發展的技能，因此 EFT 督導有相當多的引導，形式是教學與矯正性回饋，但始終顧及受督者的關係安全	督導的藝術在於讓矯正性回饋被感受為支持而非批評。督導者若以「探索者」自居，示範站在經驗邊緣、不知道但好奇的姿態，會大有幫助
諮商者	督導者促進受督者探索其人際或個人內在的現實	受督者提出可能影響治療能力的個人阻礙或生活問題時，督導者在限度內提供支持性諮商：同理，並提供一些歷程引導，協助受督者澄清感受與問題	應在單次內完成；若受督者願意，可轉介治療師。諮商是事件本位，不是持續性的。原教材的例子是：受督者對學習成為好治療師感到焦慮或無望時，督導者先同理，並詢問受督者是否想進一步探索；得到肯定答覆之後，才探索受督者的自我批評歷程，而且理想上只做一次，不超過受督者感到自在的程度，也不超過關係能承受的程度

角色	Bernard 的定義	EFT 的用法（原教材）	界線與注意事項
顧問	督導者是資源，但鼓勵受督者信任自己的想法、洞察與感受	促進受督者發展，以受督者的優勢與天賦為基礎鼓勵自我效能；採合作而非專家姿態；在示範與鼓勵受督者信任自己之間取得平衡；有時擔任受督者自身晤談經驗的歷程促進者；必要時提供知識與資訊	以示範 EFT 態度（尊重、同理、真誠、合作解決問題）作為教學的一部分

B15. 督導的一致性、合作，以及專家與共構者的辯證

督導的一致性（congruence）：原教材指出，EFT 督導強調受督者的需要與督導者的回應之間要一致。達成一致需要幾個條件：理論取向相符、任務相關、雙方投入、目標有共識。而這些條件又取決於督導者是否能信任受督者知道督導最好往哪個方向走，並與之合作。

- 一致事件（原教材例）：新手受督者表達對下次晤談的籠統擔憂，督導者跟隨這條重要線索，協助受督者深化這份經驗、把它說出來，最後以新的方式理解它的意義。
- 不一致事件（原教材例）：受督者在個案概念化上有困難時，督導者採取專家角色，直接給出個案的診斷，而不是促進並引導概念化的歷程，例如協助受督者辨識個案的核心情緒及其基模組織。

原教材指出，在 EFT 中，跟隨與引導都重要，各有其時。

合作（collaboration）：EFT 督導者不應自認是握有所有答案的絕對專家，因此不應把知識或智慧強加給受督者。督導者的姿態圍繞著「合作」，也就是有興趣的投入與平等的態度。例如，督導者可以先問受督者，個案在特定時刻感受到什麼，而不是直接說出督導者的看法。儘管如此，督導者仍對受督者與個案負有責任，並擁有來自經驗與專業的某種權威。

專家與共構者的辯證：督導者身分帶有內在的權力與被期待的專家角色：督導者一方面擁有技能與經驗，另一方面在評鑑層次決定受督者表現是否適當、哪些地方需要改進。駕馭這個辯證，意味著能從專家位置傳遞知識，同時不羞辱受督者、不強加價值或解決方法。原教材也要求督導者：

- 真誠地想知道每位受督者需要什麼，以及受督者覺得哪些做法對學習有幫助、哪些有阻礙；
- 共同建構督導目標、發展達成目標的方法、控制權力的平衡；
- 願意公開承認錯誤與誤解，並為督導中可能遇到的困難承擔自己的責任。例如：「我想我剛才說的不對；我現在明白你對個案感受的看法了。」

B16. 督導者的參與方式

原教材指出，受督者被視為改變歷程中的能動者，天生具有以自己節奏成長的能力，因此在督導中也需要被給予 Rogers 的三項條件：同理理解、一致與無條件正向關懷。督導者的具體做法包括：

- 同理探索、經驗學習、對話、示範、角色扮演、歷程引導；
- 溫和地把可能尚未被承認的議題帶進討論，或承認受督者提出的問題，並驗證受督者的經驗；
- 邀請受督者公開分享觀點，強調雙方都參與了問題，同理反映其意義，並對問題進行同理探索，發展出對困難的共同理解；

- 聽出受督者在概念上的困難，協助其回想理論與研究背景；
- 在介入方面，提供軼事式例子，或與受督者一起看好的或不好的介入錄影；
- 一起聽晤談片段，在需要回饋時暫停，提供回饋，並舉例說明當時可以用哪些不同的介入；
- 請受督者提供在特定治療任務上遇到困難的具體例子；必要時給予作業以補足知識缺口；
- 以「可以做」而非對錯的概念工作；雙方逐刻探索受督者在特定任務、任務中某一步驟，或兩者融合上的表現與困難；
- 當可能有治療上的阻礙時，深化受督者的經驗；
- 請受督者思考不同的介入選項，或練習有幫助的治療回應。

B17. 兩位作者的督導者發展歷程（作者自述）

這部分是作者的個人敘述，不是理論主張，但包含幾個有教學價值的觀點。

Greenberg 的歷程：

- 他的主要督導者是 Rogers 的學生 Laura Rice。Rice 的督導以個人中心為框架，但特別重視促進個案的資訊處理，把特定介入視為增進個案逐刻處理資訊的方式。這成為他日後聚焦「逐刻處理事件與任務」的源頭。
- 他從早期經驗中發現，看錄影與現場督導最有意義，個案討論沒什麼幫助；他也對詮釋性的概念化高度懷疑，偏好看晤談中真實的互動。
- 他描述當年訓練界的一場爭論：Rogers 把訓練視為「態度訓練」（以經驗為基礎的個人成長，培養同理的存在方式），Carkhuff (1969) 則把同理視為「技能訓練」（行為取向的明確技能訓練）。他整合兩者：一方面在督導中提供同理並做經驗性工作，協助受督者處理自己的焦慮、不勝任感、對自身情緒的恐懼，找到自己的阻礙與偏見；另一方面訓練同理的技能，並強調同理不只提供理解，也協助資訊處理與情緒處理。
- 他吸收了 Carkhuff 的「高即時性」（immediacy）與後設溝通，但不認為面質有用，尤其是對不一致處的負向面質。
- 早期他會在督導中使用雙椅對話：受督者扮演自己的個案，他扮演治療師，示範受督者可以怎麼做。
- 隨著 EFT 理論與歷程研究的發展，他的督導越來越技術導向，越來越少處理受督者自己的議題，改為轉介受督者去做個人治療。他認為個人工作對成為真正熟練的 EFT 治療師更為必要，原因不在於個人議題會造成反移情模式，而在於處理自己的情緒歷程，能擴大一個人處理他人情緒的能力。例如，要先處理自己的自我批評、失落、羞愧與憤怒，才能幫助他人做同樣的事。
- 他現在的督導花較少時間跟隨、較多時間引導，有些受督者覺得這具有威脅性或像在批評。他認為，要提供這種較具指導性的督導，需要先建立接納與肯定的整體關係框架。他也会自我揭露個人經驗與臨床經驗、推薦資源與轉介，營造「我們一起讓受督者成為更好的治療師」的感覺。

Tomescu 的歷程：

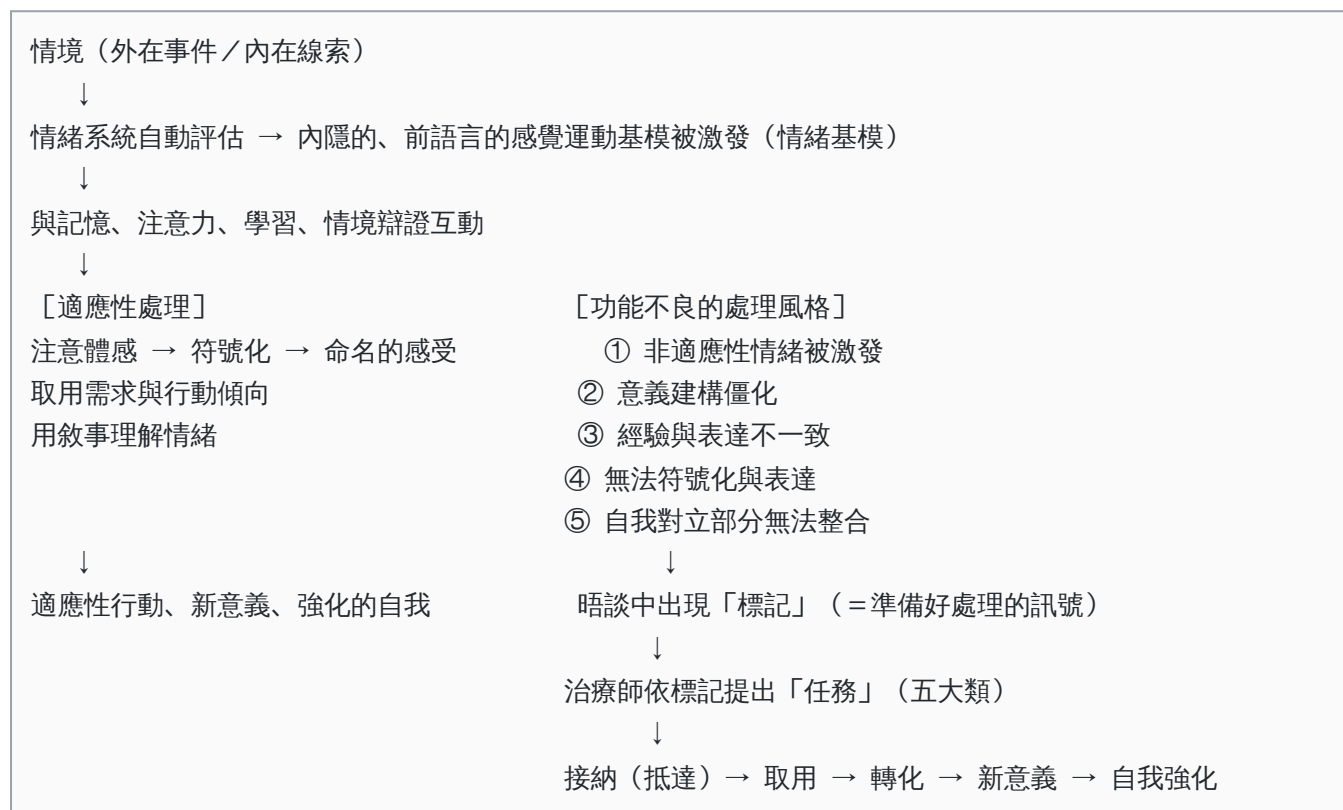
- 她在前共產時期的羅馬尼亞長大，當時的環境充滿強迫從眾與對表達的普遍恐懼。移居北美後，她才體會到不強加、合作、真正激發思考的教育與督導經驗有多珍貴。
- 她從學生時代的經驗注意到：讓她感到被投入、被激發、被認可的課，她就學得最好。她好奇的不只是督導者做了什麼不同，更是如何傳遞知識與技能，讓她感到自己真正在成長。
- Greenberg 常在督導中問她：「此時此地發生了什麼？剛剛發生了什麼？」

- 她強調督導不只關乎優秀的導師，也關乎投入而堅韌的學生。受督者常要面對各種情緒，彷彿重新經歷整個關係與社會歷史，這需要勇氣。受督者要覺察權力差距，以及失調可能造成的破壞性後果，同時學習在「為自己發聲」與「認出優秀的督導介入並接受」之間取得平衡。

C. 理論架構／概念模型

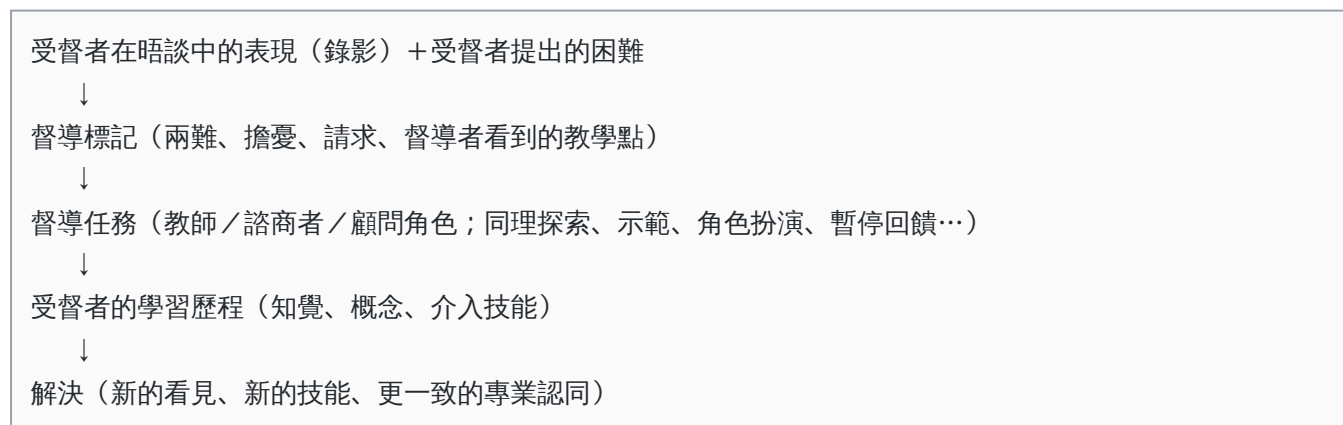
C1. EFT 的情緒處理模型（單元1層次）

依原教材內容整理如下（其中「從臨床實務角度」的串接是本教材的整理，不是原書的圖示）：



C2. 平行的督導模型

原教材在第1章已說明：督導的基本原則與治療相同（關係＋工作），並以任務分析取向辨識督導標記與任務。第2章會把它具體化為五步驟的事件模型。



兩個模型之間的界線：治療的「失功能理論」與「治療理論」不套用到受督者身上。督導促進的是學習，不是治療。

D. 實證基礎

主張	原書中的證據性質	強度與限制
EFT 是具實證支持的治療取向	原教材的描述性陳述；具體的隨機對照試驗在第6章才列出（見單元6）	第1章未提供具體研究，屬於背景主張
情緒最初是前概念、前語言的感覺運動基模，可經由語言符號化成為意識經驗	引用 Lane（2008）	屬於情緒理論的整合性論述；原書未說明研究方法細節
情緒與需求跨越文化，但表達規則不同	原教材說明依據是「EFT 的人本主義基礎」與「情緒領域的研究」，但未引用具體研究	普世主義是有爭議的立場（見 H、I），應視為理論前提，不是已確立的事實
85%–90%的治療師在執業頭15年內會成為督導者	叢書序引用 Rønnestad 等（1997）的調查	屬於描述性調查數據；抽樣背景為當時的歐美治療師，推論到台灣要謹慎
Greenberg 的歷程研究影響了他的督導方式	作者自述	屬於個人經驗陳述，不是研究證據
督導模式本身的有效性	第1章沒有提供	作者在第7章明言本模式尚待實證檢驗

結論：第1章主要是概念性與理論性的內容，加上作者的專業經驗。學生應把它理解為「一個有理論根據、以研究為基礎的取向，所提出的督導框架」，而不是「已被證明有效的督導方法」。

E. 臨床意義

臨床面向	本單元的意涵
臨床評估	評估焦點從「這是什麼疾患」擴展到「此刻情緒如何被處理」：是哪一種情緒類型？有沒有被符號化？經驗與表達是否一致？四項評估準則要交叉使用
個案概念化	以情緒基模與敘事認同作為概念化的兩個層次；把表面情緒（常是次發的）與底層的原發情緒分開（第3章會發展完整的概念化步驟）
診斷與鑑別	EFT 採歷程診斷。從臨床實務角度看，在需要正式診斷的場域，歷程診斷與疾病診斷可以並行：前者引導晤談中的介入，後者用於轉介、醫療協作與行政需求

臨床面向	本單元的意涵
治療計畫	以標記引導任務，而不是事先排定介入順序；介入是「可以做」的實驗
治療關係	跟隨與引導的辯證；治療師是歷程專家，個案是經驗專家
風險評估	第1章沒有直接處理。從臨床實務角度看，「不看病理」不代表「不評估風險」；第2章明示，遇到自殺風險時督導者會改採直接的內容指導回應
治療監控	注意個案情緒功能的逐刻變化，例如次發憤怒是否轉成原發悲傷
督導	雙重焦點（個案 + 受督者）；三種角色依時機切換；諮商者角色要守住界線；矯正性回饋要被感受為支持；督導者要承認錯誤

F. 臨床推理：「一名臨床心理學家看到這些資料後，會如何思考？」

以一個常見場景為例：個案在晤談中談到伴侶時大聲生氣。

1. 應蒐集哪些資訊？
2. 非語言線索（準則①）：聲音是聚焦的還是對外宣講的？憤怒是向外的，還是有一瞬間的哽咽或低頭？
3. 情境（準則②）：伴侶做了什麼？一般人在這種情境下會有什麼情緒？
4. 治療師自身的反應（準則③）：我聽到時感到的是被捲入的緊張，還是心疼？
5. 個案的特徵模式（準則④）：他通常在受傷時生氣，還是在被侵犯時生氣？
6. 可能的假設：
7. 原發適應性憤怒：伴侶確實越界，憤怒指向保護界線。
8. 次發反應性憤怒：憤怒遮蔽了被拒絕的受傷或被遺棄的恐懼。
9. 原發非適應性憤怒：源自童年被欺負的過度學習反應，對微小刺激就全面爆發。
10. 工具性憤怒：在家裡，生氣是讓伴侶讓步的方式。
11. 替代解釋：情緒可能同時具有多種功能；也可能是文化表達規則讓某些情緒（例如悲傷）只能以憤怒的形式出現。
12. 支持或削弱各假設的資料：
13. 同理反映「你很受傷」之後，若個案的聲音軟化並出現悲傷，支持次發假設。
14. 若個案表達後出現清晰感與明確的行動方向（「我要跟她說清楚」），支持原發適應性假設。
15. 若憤怒的強度遠超過情境，而且個案自述「每次都這樣、控制不了」，支持原發非適應性假設。
16. 若憤怒只在特定聽眾面前出現，而且個案知道它的效果，支持工具性假設。
17. 仍缺少的資訊：關係中是否有暴力或安全疑慮（這一點必須評估，屬於原書以外的一般臨床實務要求）、個案的成長史、文化背景中憤怒的意義。

18. 什麼會改變概念化？例如得知伴侶長期當眾羞辱他，某些憤怒就應重新理解為對真實侵犯的適應性反應。
19. 下一步評估：以試探性的同理探索進行測試，例如「你很生氣……而在這份生氣底下，好像還有一點什麼？」然後觀察個案的反應。個案的反應本身就是資料。

G. 臨床情境中的應用（簡例）

以下均為「情境為綜合改寫之假想案例」。

- 例一（原發適應性悲傷）：一位大學生談到從小陪伴她的阿公上個月過世，眼眶泛紅、說話變慢。治療師可以放慢速度，以同理理解讓悲傷有空間：「很想他……」。這時不急著「幫她走出來」，因為她需要先抵達悲傷。
- 例二（次發反應性情緒）：一位上班族一講到自己哭就很生氣：「哭有什麼用，我氣死自己了。」這是對悲傷的憤怒。治療師可以同理這份憤怒，並試探性地轉向底下：「好像連讓自己難過都不被允許……那份難過是關於什麼？」
- 例三（督導中的一致事件）：受督者說：「我一直在想下週那個個案，有點不安。」督導者沒有立刻回到錄影，而是跟隨這條線索：「願意多說一點那份不安嗎？」結果受督者發現，自己怕的是個案提到過的自殺念頭。此時督導者必須轉為內容指導，與受督者討論具體的風險評估步驟（銜接單元2）。這個例子也說明：跟隨受督者，可能會帶出需要督導者直接引導的議題。

H. 常見誤解與臨床陷阱

1. 把次發情緒當成核心問題。例如把「絕望」或「對伴侶的憤怒」當作要處理的目標，錯過底下的受傷、羞愧或恐懼。
2. 看到工具性情緒就認定「操弄」。這會讓個案感到被指責，破壞同盟；原教材的處理方式是好奇地探索其功能。
3. 以情緒名稱判斷情緒類型。例如認為「悲傷一定是原發」。情緒類型是功能判斷，同一種情緒可能屬於任何一種類型。
4. 過早想要改變，跳過「抵達」。急著重新框架或提供洞察。
5. 把「歷程診斷」誤解為「不必評估風險或疾病」。
6. 督導中的人格化歸因。例如督導者或受督者自己說「我就是太內向，不適合當心理師」，把歷程困難歸因於人格。
7. 督導者以專家角色直接給答案或診斷。這剝奪了受督者形成概念化的學習機會，屬於不一致事件。
8. 諮商者角色越界。例如督導演變成持續的個人治療、未徵得同意就深入受督者的個人議題、超過關係能承受的程度。
9. 「只有一種正確做法」的心態。無論是督導者給出對錯宣判，或受督者要求標準答案，都會阻礙個人化。
10. 以為讀懂理論就能在晤談中辨認。忽略知覺技能必須在具體錄影片段中學習（情性知識的問題，單元3會詳述）。
11. 把文化表達規則誤判為缺乏情緒或抗拒。例如把個案對父母的克制解讀為「沒有憤怒」或「防衛」。

12. 只憑治療師自己的感受判斷個案的情緒（只用準則③）。這有投射的風險。

1. 倫理、文化與專業考量

11. 評鑑、守門與個案福祉

督導者對個案照護品質負有倫理與法律責任，形成性評量是督導的基礎。督導同時具有評鑑性與階層性，這表示受督者的揭露永遠發生在一個有權力差距的關係中（從臨床實務角度）。

12. 權力差距

原教材承認督導者身分帶有內在的權力與專家期待。Tomescu 也從受督者的角度指出，要覺察權力差距與失調的破壞性後果。從臨床實務角度看，在台灣的碩士實習制度中，督導者常同時是評分者，受督者可能因此不敢表達不同意見。這正是督導者需要主動、以共同承擔的方式開啟對話的理由（單元4會詳述）。

13. 督導與治療的界線（雙重關係）

原教材給出清楚的操作界線：

- 督導不在督導中對受督者明確地進行治療。
- 諮商者角色：先詢問受督者是否願意探索；只做一次；以事件為本位；不超過受督者感到自在的程度，也不超過關係能承受的程度；需要時轉介。
- Greenberg 認為個人治療有助於擴大處理情緒的能力，但應在督導之外進行。

14. 文化：共同核心與表達規則

原教材的立場包括：

- 所有人在核心上有相同的情緒與需求（生存、成長、依附與歸屬、被重視與被認可），但表達與溝通情緒的規則因文化而異，並且是不同信念系統、習俗與態度的一部分。
- 取得文化知識的途徑是教育、好奇、對差異的直接經驗，以及高度敏感與開放。
- 原教材的例子：亞洲或集體主義文化的個案，可能因為尊敬並服從長輩的文化信念，而較難對父母或權威表達憤怒；良好的同盟、同理與對這些規則的理解，能隨時間抵達共同的情緒核心。

批判性提醒（從臨床實務角度）：

- 「人在情緒上相同」是 EFT 的理論前提。跨文化心理學對於情緒類別與需求是否普世，仍有不同觀點，原書並未處理這些爭論。
- 「抵達共同的情緒核心」如果被理解為「最終要讓個案向父母表達憤怒」，可能把特定文化的價值（例如個人化的自我肯定）當成普世目標。更謹慎的做法是：讓個案覺察並命名自己的情緒，至於如何表達、是否向對方表達，由個案依其價值決定。
- 「集體主義」是一個粗略的分類，同一文化內的個別差異可能大於文化之間的差異。避免把文化當成預測個案情緒的刻板印象。

15. 保密

原書的案例資料都已改寫以保護保密性（p. 26 註1）。本套教材也遵循同樣原則。學生在工作單中使用實習個案時，必須去識別化，並遵守實習機構的規定。

J. 學習者必須帶走的核心知識

層次	內容
必須記住	EFT 的六大原則；四種情緒類型的定義與各自的處理方式；情緒評估的四項準則；功能不良處理的五種機制；督導者的三種角色；任務的五大類別；督導的定義（介入、較資深、持續關係、評鑑與守門）
應該理解	為什麼感受是被建構的（辯證建構主義）；為什麼 EFT 以處理風格取代精神病理；為什麼必須先抵達才能離開；知覺技能與概念知識的差別；督導為什麼有雙重焦點；督導為何不是治療
能夠應用	在晤談片段中判斷情緒類型並選擇回應方向；以四項準則交叉評估；以「可以做」的語言給回饋；辨識督導中的一致與不一致事件
能夠批判性思考	「個案不經驗精神病理」在不同場域的適用限度；普世情緒觀的文化限制；督導者權力與「合作」之間的張力；督導與治療界線的判斷；本模式目前缺乏直接實證支持

§3 核心概念洞見

洞見一：情緒的「類型」是功能判斷，決定了介入方向

- 核心命題：同一種情緒名稱，例如憤怒，可能是原發適應性、原發非適應性、次發反應性或工具性情緒。四種類型需要的回應完全不同：分別是取用並允許、接近並轉化、向下探索、探索其人際功能。
- 臨床重要性：回應錯了類型，治療就會走錯方向。例如深化次發憤怒，只會讓個案更激動而沒有新的意義；把原發適應性憤怒視為要被安撫的東西，則會剝奪個案保護界線的資源。
- 對臨床推理的影響：治療師不再問「他在氣什麼」，而是問「這份憤怒此刻在做什麼？它底下有沒有別的東西？說出來之後，他是更清楚了，還是更卡住了？」
- 例子（假想）：一位個案每次談到母親就生氣。治療師試探地同理「好像很氣，但也有點累？」之後，個案沉默，接著說「我其實只是想她看看我」，聲音變小。憤怒轉為悲傷與渴望，這支持「次發」假設。
- 常見學生誤解：以為「悲傷一定比憤怒深」或「憤怒一定是次發的」。原發適應性憤怒是健康的資源，例如面對侵犯時。
- 教學重點：先判斷情緒在此刻的功能，再決定要深化、轉化、探索底下，還是探索它的目的。

洞見二：歷程診斷對個案與受督者雙向適用

- 核心命題：EFT 把個案理解為「處理風格功能不良」，而不是「人本身功能不良」；督導也以同樣的方式理解受督者：困難屬於歷程，而不是人格缺陷。
- 臨床重要性：這個立場讓治療與督導的焦點落在可以改變的歷程上，並降低羞愧。對受督者而言，被評價人格是最容易引發防衛、阻礙學習的經驗。
- 對臨床推理的影響：看到受督者「每次個案哭就轉移話題」，督導者問的不是「他是不是太焦慮、不適合」，而是「那一刻發生了什麼？他怕什麼？他需要學會哪個技能？」
- 例子（假想）：受督者自責：「我是不是太內向了？」督導者回應：「我們先看看那一刻你心裡發生了什麼。我猜那不是『內向』，而是一種我們可以一起處理的慌。」
- 常見學生誤解：以為歷程診斷就是「不做任何評估」。歷程診斷是更精細的評估，而且不排除風險評估與正式診斷的需要。
- 教學重點：把「他是什麼樣的人」換成「此刻發生了什麼歷程」，改變才有入口。

洞見三：先抵達，才能離開

- 核心命題：改變的前提是接納：個案必須先完整經驗並接納當下的自己，才能離開這個狀態。
- 臨床重要性：新手治療師常出於善意，急著讓個案「好起來」，例如提供洞察、重新框架或建議，結果跳過了情緒被接觸與被承認的步驟。
- 對臨床推理的影響：治療師要評估的不只是「個案需要改變什麼」，還有「個案已經抵達這個感受了嗎？」如果還沒有，下一步是協助抵達，而不是推動離開。
- 例子（假想）：個案說：「我知道我不該那麼依賴他，我要馬上改。」治療師沒有立刻討論怎麼改，而是回應：「好像很急著要自己不要依賴……那份依賴裡，是什麼在需要他？」
- 常見學生誤解：以為「接納」就是被動地什麼都不做。接納是一種主動的歷程工作，治療師需要引導個案接觸並承認經驗。
- 教學重點：在推動改變之前，先確認個案已經抵達；督導中，受督者也需要先被理解，才能學習。

洞見四：知覺技能，也就是知道「何時」，比知道「如何」更難學

- 核心命題：原教材區分知覺技能（知道何時介入、能在現象出現時注意到它）與介入技能（知道如何介入）。概念理解不能保證能在情境中應用；知覺技能只能透過具體例子學習。
- 臨床重要性：很多學生能背出「未竟事務標記」的定義，卻在晤談中聽不出個案語氣的那一下轉變。錯過時機，再好的介入也無從施展。
- 對臨床推理的影響：學習方式要改變，從「讀更多書」轉為「在錄影中一次次地被指出：就是這裡」。
- 例子（假想）：受督者讀完所有關於次發情緒的文獻，但在錄影中沒注意到個案說「我不在意」時手握成拳。督導者暫停錄影：「你看這裡，他的手。」
- 常見學生誤解：以為臨床經驗會自然帶來敏感度。沒有被指出、被命名的經驗，常常只是重複同樣的盲點。
- 教學重點：錄影加上督導者的當場指出，是培養「何時」這種知覺的主要途徑。

洞見五：矯正性回饋要被感受為支持，而這靠的是關係與姿態

- 核心命題：EFT 督導有大量的引導與矯正性回饋，但督導的藝術在於讓回饋被感受為支持而非批評。關鍵在於接納與肯定的關係框架、「可以做」的語言，以及督導者以好奇的探索者自居。
- 臨床重要性：受督者一旦感到被批評，會轉為順從或防衛，學習就停止了。這也會以平行歷程的方式出現在受督者對待個案的方式中（從臨床實務角度）。
- 對臨床推理的影響：督導者不只問「什麼是對的回應」，也問「我要如何說，才能讓他聽得進去」；督導者也要願意承認自己的錯誤。
- 例子（假想）：督導者說：「在這裡可以做的有好幾種，其中一種是停下來反映她的悲傷。你覺得哪一種最像你？」這比「你這裡做錯了，應該反映悲傷」更容易被接受。
- 常見學生誤解：以為支持性的督導就是不給批評。原教材明言 EFT 督導有大量矯正性回饋，重點在如何給。
- 教學重點：矯正性回饋的效果，取決於它是不是在一段接納的關係中，以「可能性」而非「宣判」的形式提供。

§4 關鍵原文引述

引文均為原書短句直接引用，中文為本教材的精確意譯。

引述一

原文：

“the client has to arrive at a place before he/she can leave that place”

中文意譯：「個案必須先抵達一個地方，才能離開那個地方。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 1, Theoretical Framework of EFT, p. 6.

臨床意義：這句話濃縮了 EFT 對改變的基本立場：接納經驗是改變的前提。個案尚未觸及並承認的情緒，無法被轉化。它提醒治療師，在提供洞察、重新框架或技巧之前，先確認個案是否已經抵達自己的感受。

教學意義：碩士生最常見的陷阱是「急著幫忙」。這句話提供一個自我檢核的問題：「我是在協助他抵達，還是在推他離開？」原書第5章也在「引導與教導」的困難中再次引用這個原則，說明它貫穿整個模式。

引述二

原文：

“some of the art of supervision is giving corrective feedback in a manner that is felt as support rather than criticism.”

中文意譯：「督導的一部分藝術，在於以讓人感受為支持、而非批評的方式給予矯正性回饋。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 1, Supervisor's Role, p. 19.

臨床意義：EFT 督導有大量的技術性引導。這句話說明，技術回饋能否被吸收，取決於關係的品質與回饋的方式。原書也提到，受督者曾告訴 Greenberg，他們過去從未在不感到被批評的情況下接受批評性回饋。

教學意義：對受督者來說，這句話提供了一個可以期待、也可以主動請求的督導品質。對未來的督導者而言，這是一項需要刻意練習的技能，而不是個性使然。

引述三

原文：

“clients are not seen as experiencing psychopathology, but rather as having a dysfunctional style of emotional processing.”

中文意譯：「個案不被視為經驗著精神病理，而是被視為擁有一種功能不良的情緒處理風格。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 1, Theoretical Framework of EFT, p. 6.

臨床意義：這是 EFT「歷程診斷」立場最鮮明的表述。它把臨床注意力從疾病標籤轉向可以在晤談中介入的歷程，並延伸到督導：受督者的困難也屬於歷程，而不是人格缺陷。

教學意義：這句話同時是洞見，也是值得批判的主張。學生應能說明它對介入的價值，也能評估它在需要正式診斷、風險評估與醫療協作的場域中有什麼限制。

§5 臨床推理框架

本單元的推理框架聚焦兩個情境：晤談中評估一個情緒，以及督導中理解受督者的困難。兩者使用同一組八個步驟。

5.1 八步臨床推理：評估晤談中的一個情緒

步驟	問題	EFT 單元1的具體做法
① 我現在知道什麼？	可觀察到的資料	非語言表達（臉、聲音、說話方式）；個案說出的情緒詞；情境內容
② 我還不知道什麼？	資料的缺口	這份情緒底下有沒有別的？個案平常在這類情境的反應模式？文化中這種情緒的表達規則？

步驟	問題	EFT 單元1的具體做法
③ 我正在形成什麼假設？	情緒類型的暫定判斷	原發適應性／原發非適應性／次發反應性／工具性（可能不只一種）
④ 有哪些替代解釋？	至少列出另一種類型	例如「看似次發的憤怒，其實是對真實侵犯的原發適應性憤怒」；也要考慮文化表達規則
⑤ 什麼資料可以支持或推翻這些假設？	四項評估準則交叉檢驗	準則①非語言；②常模性的情緒反應；③治療師自身的共鳴；④個案的特徵模式。對試探性同理的反應是最直接的檢驗
⑥ 下一步應該評估什麼？	設計一個可以觀察的回應	例如同理臆測「在生氣底下，好像還有一點受傷？」，然後看聲音是否軟化
⑦ 哪些因素可能改變我的判斷？	新資料	文化背景、關係中的真實侵犯、安全疑慮、身體或醫療因素、個案對回應的反應
⑧ 如何轉化成臨床決策？	依類型選擇方向	取用並允許／接近、符號化、再以另一種情緒轉化／向下探索原發情緒／好奇地探索人際功能

5.2 八步推理：督導中理解受督者的困難（受督者自我反思版）

步驟	問題	單元1的具體做法
① 我知道什麼？	錄影中實際發生了什麼	我說了什麼、個案怎麼反應、我那時的身體與情緒反應
② 我不知道什麼？		個案那一刻在經驗什麼？我錯過了什麼線索？
③ 我的假設？	困難屬於哪一類	知覺（沒看到）？概念（不懂）？介入（不知道怎麼做）？個人反應（我怕）？
④ 替代解釋？	避免人格化歸因	把「我就是不適合」改寫為可處理的歷程
⑤ 支持或推翻的資料？		回看錄影：同樣的模式在其他片段是否也出現？
⑥ 下一步？	我要帶什麼進督導	一個具體標記（錄影時間點＋我的問題）
⑦ 什麼會改變我的判斷？		督導者的觀察、個案下次的反應
⑧ 臨床決策？	下次晤談要嘗試的「可以做」	一個要練習的回應，以及一個需要時可以求助的界線（例如個人議題轉介）

5.3 與其他概念化框架的關係

- EFT 歷程診斷式概念化是本單元的主要框架。第3章會發展為兩階段、十一步驟的完整模式。
- 5P 或生理—心理—社會概念化（從臨床實務角度）：原書不使用這些框架，並且明言 EFT 概念化不描繪人格、防衛或跨時間重複的關係模式（第3章）。在需要跨專業溝通的場域，學生可以把兩者並行：5P 用於整體臨床報告與團隊溝通；EFT 歷程概念化用於決定晤談中的逐刻介入。並行時要注意，不要把 5P 中的「素質因素」反過來當作對個案的人格評價，否則會違背歷程診斷的精神。
- 文化形成（cultural formulation）：用來補足原書對文化討論較簡略的部分，特別是情緒表達規則與個案本身的價值（從臨床實務角度）。